

Asma na criança · crise e manutenção

Na criança, a crise asmática responde a SABA com espaçador/máscara e corticoide sistêmico precoce. Controle crônico evita idas à emergência — corticoides inalatórios são a base no persistente.

Espaçador > nebulização na maioria

Dica - Espaçador > nebulização na maioria

Dose adequada de salbutamol com espaçador é tão eficaz quanto nebulização na crise leve-moderada e reduz aerossolização — ponto clássico de prova.

Fluxo: gravidade !' broncodilatação seriada + corticoide !' alta com plano ou internação.

Crise asmática pediátrica

Avaliar -> SABA + corticoide -> decidir destino

Avaliar gravidade

fala / SatO2 / esforço

SABA + corticoide

espaçador / EV se grave

Destino

alta planejada ou internar

Manutenção (ideia)

- CI (budesonida/beclometasona etc.) no persistente; associar LABA se preciso (idade/indicação)
- Educação: técnica inalatória, plano de crise, evitar gatilhos
- Comorbidades: rinite, refluxo, obesidade, tabagismo passivo
- Corticoide oral de manutenção só em casos refratários — não é rotina

Crise — intensificação

Gravidade | Conduta

Leve-moderada | SABA seriado + corticoide VO

Grave | O₂ , + SABA ± ipratrópio + corticoide; considerar MgSO₄ „

Ameaça à vida | UTI / via aérea; não sedar fora de suporte

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Lactente sibilante de 1ª crise não é 'asma confirmada'. Trate o broncoespasmo agudo, mas reserve o rótulo de asma para padrão recorrente + contexto atópico/idade.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1